تۆتىنجى بۆلۈم: كېسەللىك ئالامەتلىرى ۋە دىئاگنوز ئىلمى

كېسەللىك ئالامەتلىرى ۋە دىئاگنوز ئىلمى — كېسەللىكلەرنى تونۇپ، نام قويۇش ۋە بىر-بىرىدىن پەرقلەندۈرۈشنى ئۆگىتىدىغان پەندۇر.

بۇ ئىلىم كېسەللىك ئالامەتلىرى ئىلمى ۋە دىئاگنوز ئىلمى دەپ ئىككىگە بۆلىنىدۇ.

1. كېسەللىك ئالامەتلىرى ئىلمى

كېسەللىك ئالامەتلىرى دېگەن تۈرلۈك كېسەللىكلەر تۈپەيلىدىن بىمارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ھالىتىدە ئىپادىلىنىپ چىقىپ، بىمار ئۆزى ھېس قىلغان نورمالسىز سېزىم، بىئاراملىق ياكى بەزى يېقىمسىزلىقلار كېسەللىك ئالامەتلىرى دېيىلىدۇ.

كېسەللىك ئالامەتلىرى، كېسەللىكلەرنى تونۇپ نام قويۇش ۋە پەرق ئېتىپ توغرا دىئاگنوز قويۇشنىڭ ئاساسىي يىپ ئۇچى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ كۆپىنچىسى بەدەندە ھەرخىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن مىزاج ۋە خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇپ، مىزاج بۇزۇلۇش خاراكتېرلىك كېسەللىك ئۆزگىرىشى، شەكىل بۇزۇلۇش خاراكتېرلىك كېسەللىك ئۆزگىرىشى ياكى پۈتۈنلۈك بۇزۇلۇش خاراكتېرلىك كېسەللىك ئۆزگىرىشى يۈز بەرگەندە شەكىللىنىپ چىقىدۇ.

1) قىزىتما

ئادەم بەدىنى تېمپېراتۇرىسىنىڭ، نورمال دائىرىدىن ئېشىپ كېتىپ، كېچە-كۈندۈزدىكى ئۆزگىرىشى بىر سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى بولۇشى «قىزىتما» دەپ ئاتىلىدۇ.

ساغلام بىر كىشىنىڭ نورمال بەدەن تېمپېراتۇرىسى 35.5 سېلسىيە گرادۇستىن 36.5 ۋە 37 سېلسىيە گرادۇس ئەتراپىدا بولىدۇ. بەدەن تېمپېراتۇرىسى تېرمومېتىر بىلەن ئۆلچىنىدۇ، يەنى تېرمومېتىرنى ئېغىزغا سېلىش، قولتۇققا قويۇش ۋە مەقئەت تۈز ئۈچەيگە كىرگۈزۈپ قويۇش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئۆلچىنىدۇ.

قىزىتمىنىڭ يوقىرى تۆۋەن دەرىجىسىگە ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ.

بىرىنجى تۆۋەن قىزىتما، ساغلام بىر كىشىنىڭ نورمال بەدەن تېمپېراتۇرىسى 35.5 سېلسىيە گرادۇستىن 36.5 ۋە 37 سېلسىيە گرادۇس ئەتراپىدا بولىدۇ. قىزىتما يۇقىرى تۆۋەن

دەرىجىسىگە ئاساسەن 37 سېلسىيە گرادۇستىن 38 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولغان قىزىتما تۆۋەن قىزىتما دېيىلىدۇ.

ئىككىنچى ئوتتۇرھال قىزىتما، 38.1 سېلسىيە گرادۇستىن 39 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولغان قىزىتما ئوتتۇراھال قىزىتما دېيىلىدۇ.

ئۈچىنچى يۇقىرى قىزىتما، 39.1 سېلسىيە گرادۇستىن 40 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولغان قىزىتما يۇقىرى قىزىتما دېيىلىدۇ.

تۆتىنچى پەۋقۇلئاددە يۇقىرى 41 سلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى قىزىتمىنى پەۋقۇلاددە يۇقىرى قىزىتما دېيىلىدۇ.

2) ئاغرىق

ئىچكى-تاشقى سەۋەبلەرنىڭ بەدەندە پەيدا قىلغان كېسەللىك ئۆزگىرىشىدىن مۇسكۇل، توقۇلما ۋە نېرۋىلاردىكى بېسىلىش، سوزۇلۇش ۋە تارتىشىش قاتارلىق ھېس تۇيغۇ سىگناللىرىنى نېرۋا ئۇچلىرى يۇلۇن ۋە مېڭىگە ئېلىپ بېرىشتىن پەيدا بولغان سېزىم «ئاغرىق» دەپ ئاتىلىدۇ.

ئاغرىق، ئادەتتە چىڭقىلىپ ئاغرىش، لوقۇلداپ ئاغرىش، كېسىلىپ ئاغرىش، سانجىلىپ ئاغرىش، كۆيۈشۈپ ئاغرىش ۋە ئېسىلىپ ئاغرىش قاتارلىقلار بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

ئاغرىق بەدەننىڭ بىرەر يېرىنىڭ زەخمىلەنگەنلىكىنى، ياللۇغلانغانلىقى ياكى خەتەرگە دۇچ كەلگەنلىكى توغرىسىدا مېڭىگە بېرىدىغان ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى دۇر.

ئاغرىققا دىققەت قىلىپ، دىئاگنوزنى مۆلچەرلەش، ئاغرىقنىڭ ئورنى، ۋاقتى، خاراكتېرى قاتارلىقلارغا دىققەت قىلىش ئارقىلىق توغرا بولغان كېسەللىك دىئاگنوزغا ئېرىشىش مۇمكىنچىلىكى بۇلىدۇ.

2. دىئاگنوز ئىلمى

دىئاگنوز ئىلمى — كېسەللىك ئالامەتلىرى ۋە بەدەن بەلگىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ ھەرخىل تەكشۈرۈش ئۇسۇللىرى بىلەن تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش ئارقىلىق، كېسەللىكلەرنى تونۇپ توغرا نام قويۇشنى ئۆگىتىدىغان پەن.

كېسەللىكلەرنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش — قاراپ تەكشۈرۈش، سوراپ تەكشۈرۈش، تومۇر تۇتۇپ تەكشۈرۈش، چېكىپ تەكشۈرۈش، تىڭشاپ تەكشۈرۈش، پۇراپ تەكشۈرۈش ۋە قوشۇمچە تەكشۈرۈشتىن ئىبارەت يەتتە تۈرگە بۆلىنىدۇ.

1) قاراپ تەكشۈرۈش

قاراپ تەكشۈرۈش، كېسەللىكلەرنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاشتا ئۆزى ئاددىي ھەم مۇھىم بولغان تەكشۈرۈش ئۇسۇلى بولۇپ، دوختۇر بىلەن بىمار يۈز كۆرۈشكەندىن كېيىنلا باشلىنىپ كېتىدۇ.

قاراپ تەكشۈرۈشتە بەدەننى سىستېمىلىق كۆزىتىپ بەدەننىڭ ئومۇمى قىياپىتىنى كۆزىتىش، تىل رەڭگى ۋە تىل كېزىنى كۆزىتىش، روھىي ھالىتىنى كۆزىتىش، چىراي ئىپادىسىگە قاراش، بەدەن ھالىتىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى كۆزىتىش قاتارلىقلارغا قاراپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

(1) بەدەننىڭ ئومۇمىي قىياپىتىنى كۆزىتىش، بەدىنى قاۋۇل سېمىز كىشىلەردە مېڭە - يۈرەك قان تومۇر كېسلى بولۇش ئېھتىمالى يۇقىرى بولىدۇ. بەدەن تۈرىقى ئورۇق-ئاجىز كىشىلەردە ئاشقازان، ئۈچەي - ئۆپكە كېسەللىكلىرى بولۇش ئېھتىمالى يۇقىرى بولىدۇ.

(2) تىل رەڭگى ۋە تىل كېزىنى كۆزىتىش

بىرىنچى تىلنىڭ قىزىللىقى، بەدەندە قان خىلتى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەنلىكىنى ۋە ئىسسىقلىقنىڭ يۇقىرى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

ئىككىنچى تىلنىڭ پارقىراقلىقى، ئۆپكىدە كېسەللىك بارلىقىنى ۋە بۆرەك ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

ئۈچىنچى تىلنىڭ كۆكۈش بولىشى، بەدەننىڭ مەلۇم يېرىدە قان قېيىش ۋە قان-تومۇردا توسالغۇ بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

تۆتىنچى تىلنىڭ ئۈستىدە نېپىز ئاق گەز باغلاپ قېلىش، بەلغەم خىلتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى بولۇپ، بەدەندە نەملىك ياكى سوغۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكتىن دېرەك بېرىدۇ.

CamScanner ile tarandı

بەشىنچى تىلنىڭ ئۈستىدە نېپىز كۆكۈش گەز باغلاپ قېلىش، سەۋدا خىلتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى بولۇپ، بەدەندە قۇرۇقلۇق ياكى سوغۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

ئالتىنچى تىل ھەرىكىتىنىڭ يۇقىرى بولۇشى، مېڭىگە قان چۈشۈش ئېھتىماللىقى، ھەرىكىتىنىڭ تۆۋەن بولۇشى بولسا مېڭىگە قان يېتىشمەسلىكى ۋە تۇتقاقلىق كېسەل بولۇش ئېھتىماللىقى كۆرسىتىدۇ.

يەتتىنچى تىل ئۈستىدە نېپىز سېرىق گەز باغلاپ قېلىش، سەپرا خىلتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى بولۇپ، بەدەندە قۇرۇقلۇق ياكى ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. كۆپىنچە، جىگەر كېسىلى بار كىشىلەرنىڭ تىل گېزى سېرىق بولۇپ قالىدۇ.

(3) روھىي ھالىتىنى كۆزىتىش. روھىي ھالىتى ساغلام كىشىلەرنىڭ روھىي ھالىتى ۋە ئەس-ھوشى ئۇچۇق بولىدۇ. روھىي ھالىتى تۆۋەن ئادەمنىڭ چىرايى تۇتۇق، كۆزىنىڭ نۇرلىرى نۇرسىز، سۆزلىرى مەلتۇك، مەزمۇنىنىڭ تۇتۇمى يوق، ئەس-ھوشى جايىدا ئەمەس بولۇپ، كېسەللىكىنىڭ نېرۋا خاراكتېرلىك روھىي ئاجىزلىقتىن بولغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

(4) چىراي ئىپادىسىگە قاراش، كۆپىنچە كېسەللىكلەر چىراي كۆرۈنۈشىدە ئىپادىلىنىپ قالىدۇ. مەسىلەن: يۇقۇرى قىزىتما، ئاغرىش، نەپەس قىيىنلىشىش قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان كېسەل كىشىنىڭ چىرايىدىكى جىددىيەتلىك، مەڭزىنىڭ قىزىرىشى، نەپەسىنىڭ تېزلىششى قاتارلىقلار ئۆتكۈر كېسەللىكلەرنىڭ بارلىقىدىن دېرەك بىرىدۇ.

كېسەللىك چىرايى زەئىپ، كۈچسىز، ئورۇق، چىرايلىرى تاتارغان، كەيپىياتى سۇس بولۇش، سوزۇلما خاراكتېرلىق كېسەللىكلەردىن جىگەر قېتىش، ھەرخىل ئۆسمە، تۇبېركۇلۇز قاتارلىقلارنىڭ بولۇش مۇمكىنچىلىكىنى بىلدۈرىدۇ. يۈزىنىڭ تاتىرىپ كېتىشى، قان ئازلىقتىن، يۈزىنىڭ سارغىيىپ قېلىشى تال ۋە ئاشقازاندا كېسەللىك بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ. يۈزىنىڭ نەم ۋە قىزىللىقى ئۇ كىشىدە قىزىتما، ئۆپكە ياللۇغى ۋە يارا- يېرىكلىق ئىششىق بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ. كالپۇكلىرىنىڭ كۆكىرىشى ئۆپكىدە قان قايغان، بەدەنگە ئوكسىگېن يېتىشمەسلىك، قان-تومۇرلاردا توسالغۇلارنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

CamScanner ile tarandı

2) سوراپ تەكشۈرۈش- سوراپ تەكشۈرۈش تېۋىپنىڭ بىمار ياكى بىمارغا بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك كىشىلەر بىلەن سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق كېسەللىكنىڭ كېلىپ چىقىشى، تەرەققىياتى، ۋە ھازىرقى ئەھۋالىنى سىستېمىلىق ئىگىلەش ۋە نۆۋەتتىكى ئۆزگىرىش جەريانلىرىنى ئېنىقلاپ چىقىش، كېسەلگە دىئاگنوز قويۇشتىكى ئاساسلىق تەكشۈرۈش ئۇسۇلىدۇر.

كېسەللىك تارىخىنى خاتىرلەشتە سوراپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق بىمارنىڭ كېسەللىك ئەھۋالىنى ئومۇمىيۈزلۈك ئىگىلەپ، دىئاگنوزنى مۇقىمداش، داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى بەلگىلەشتە كەم بولسا بولمايدىغان يازما ماتېرىيالدىن ئىبارەت.

كېسەللىك تارىخىنى خاتىرلەشتە سوراپ تەكشۈرىدىغان مەزمۇنلارنى تۆۋەندىكىدەك توققۇز تۈرگە يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ.

(1) بىمارنىڭ ئادەتتىكى ئومۇمىي ئەھۋالى؛ بىمارنىڭ ئىسىم-فامىلىسى، جىنسى، يېشى، مىللىتى، كەسپى، يۇرتى، ئادرېسى، نىكاھلىنىش ئەھۋالى قاتارلىق بىمارنىڭ ئومۇمىي ئەھۋاللىرىنى بىلىش ئارقىلىق كېسەللىك ئەھۋالىغا قارىتا دەسلەپكى چۈشەنچىگە ئىگە بولغىلى بولىدۇ.

(2) مۇھىم زارى؛ بىمار ئۆزى ھېس قىلغان، بىمارنى ئەڭ ئازابلاۋاتقان بىر ياكى بىر قانچە خىل كېسەللىك ئالامىتى، بەدەن بەلگىسى داۋاملىشىش ۋاقتى، ھەم مۇشۇ قېتىم بىمارنىڭ كېسەل كۆرسىتىشكە كېلىشىدىكى ئەڭ ئاساسلىق سەۋەبى مۇھىم زارى دەپ ئاتىلىدۇ.

مۇھىم زارى، بىماردا ئەڭ ئازابلىنىش پەيدا قىلغان بىرنەچچە مۇھىم ئالامەت ياكى ئەڭ روشەن بەدەن بەلگىسى ۋە ئۇنىڭ خۇسۇسىيىتى، داۋاملىشىش ۋاقتى قاتارلىقلارنى ئۆز-ئىچىگە ئېلىشى لازىم. مۇھىم زارى، ئىنتايىن چۈشىنىشلىك، قىسقا، ئېنىق، ئىخچام يېزىلىشى تەلەپ قىلىنىدۇ.

مەسىلەن: بىماردا توڭۇپ تىترەش، قىزىش، ئوڭ كۆكرەك ئاغرىش ئالامەتلىرى پەيدا بولغىلى ئۈچ كۈن، ئېغىرلاشقىلى ئىككى سائەت بولغان.

(3) ھازىرقى كېسەللىك تارىخى؛ پۈتۈن كېسەللىك تارىخىنىڭ ئاساسىي تەركىبىي قىسمى بولۇپ، مۇھىم زارىنى ئاساس قىلىپ، شۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولغاندىن تارتىپ تاكى

CamScanner ile tarandı

دوختۇرغا كۆرۈنگۈچى بولغان ئارىلىقتىكى تەرەققىياتى، ئۆزگىرىش جەريانى، دىئاگنوز ۋە داۋالاش ئەمەلىيىتى قاتارلىق جەريانلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

(4) ئۆتمۈش كېسەللىك تارىخى؛ بىمارنىڭ بۇرۇنقى سالامەتلىك ئەھۋالى ۋە بۇرۇن گىرىپتار بولغان كېسەللىكلىرى، سىرتقى زەخمە، ئوپېراتسىيە، ئالدىنى ئېلىش ۋاكسىنىسى سالدۇرغان سالدۇرمىغانلىقى، زەھەرلىنىش، قان ئالدۇرغان، قان سالدۇرغان تارىخىنىڭ بار يوقلىقى، بولۇپمۇ ھازىرقى كېسەللىك بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان كېسەللىكلەرنى سوراش لازىم.

(5) شەخسىي كېسەللىك تارىخى؛ بىمارنىڭ ئائىلە مۇھىتى، تۇغۇلغان جايى، ئولتۇراقلاشقان ئورنى، ۋاقتى، بولۇپمۇ يۇقۇملۇق ۋە يەرلىك كېسەللىكلەر تارقالغان جايلارغا بارغان بارمىغانلىقى، مەدەنىيەت سەۋىيىسى، شەخسىي ئىدىيۋى ئەھۋالى، ھاراق-تاماكا ئىستېمال قىلىش تارىخىنىڭ بار يوقلۇقى، كەسپى ۋە خىزمەت شارائىتى، ئەمگەك شارائىتى، ياخشى كۆرىدىغان نەرسە، ئىشلار، تازىلىققا ئېتىبار بېرىش ئەھۋالى، ئوزۇقلىنىش ئادىتى ۋە مىقدارى، تۇرمۇش ئادىتى قاتارلىقلارنى سوراش لازىم.

(6) ھەيز تارىخى؛ تۇنجى قېتىم ھەيز كۆرگەن يېشى، ھەيز دەۋرى، ھەيز كېلىش كۈن سانى، ھەيز خۇنىنىڭ مىقدارى، رەڭگى، ھەيز مەزگىلىدە كۆرۈلىدىغان ئالامەتلەر، ئاغرىتىپ ھەيز كېلىش، ئاق خۇن بار يوقلۇقى، ھەيز قىنىغا يات ماددىلارنىڭ ئارىلىشىپ كېلىش ئەھۋالىنىڭ بار يوقلۇقى، ئاخىرقى قېتىملىق ھەيز كېلىش ۋاقتى، ھەيز توختىغان ۋاقتى، يېشى قاتارلىقلارنى سوراش لازىم.

(7) نىكاھلىنىش تارىخى؛ بىمارنىڭ نىكاھلانغان نىكاھلانمىغانلىقى، قانچە قېتىم نىكاھلانغانلىقى، تۇنجى نىكاھلىنىش يېشى، يولدىشىنىڭ نىكاھلىنىش يېشى، سالامەتلىك ئەھۋالى، يولدىشى ئۆلۈپ كەتكەن بولسا ئۆلۈشىنىڭ سەۋەبى، ۋاقتى قاتارلىقلارنى سوراش لازىم.

(8) تۇغۇت تارىخى؛ ھامىلدارلىق ۋە تۇغۇت قېتىمى، يېشى، تەبىئىي تۇغۇت قېتىم سانى، سۈنئىي ئۇسۇلدا قىردۇرغان، بويىدىن ئاجرىغان قېتىم سانى، ئۆلۈك تۇغۇش، غەيرىي تۇغۇلۇش ئەھۋالىنىڭ بار يوقلۇقى، تۇغۇتتا ئەگىشىپ كەلگەن قوشۇمچە كېسەللىكنىڭ بار

يوقلۇقى، هامىلدارلىقتىن زەھەرلىنىش، تۇغۇت قىزىتمىسى، تۇغۇتتىن كېيىنكى چوڭ قاناش، يۇقۇملىنىش ئەھۋالىنىڭ بار يوقلۇقى، تۇغۇتتىن ساقلىنىش تەدبىرلىرىنى قوللانغان قوللانمىغانلىقى قاتارلىقلارنى سوراش لازىم.

(9) ئائىلە كېسەللىك تارىخى؛ بىمارنىڭ ئاتا-ئانىسى، ئاكا-ئۇكا، ئاچا-سىڭىل ۋە ئوغۇل-قىزلىرىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالى، ئىرسىيەتلىك كېسەللىكنىڭ بار يوقلۇقى، ئەگەر ئۆلگۈچىلەر بولسا ئۆلۈشىنىڭ سەۋەبى، يېشى قاتارلىقلارنى سوراش لازىم.

CamScanner ile tarandı